

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

Сценарій.

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася вагітна жінка 23 років.

Вагітність II, 32 тижні. Скарги на підвищення АТ. З перенесених захворювань відмічає ГРВЗ, дитячі інфекції. Менструальна функція до вагітності не порушена. Серцево-судинна та дихальна системи без порушень. Перша вагітність закінчилась передчасними пологами. Загальний стан задовільний. АТ 150/90 мм. рт. ст. При піхвовому дослідженні - Матка в фізіологічному тонусі. Спинка плода ліворуч та кпереду. Передлежить голівка плода. ЧСС плода 140 уд / мин. Шийка матки вкорочена, зовнішнє вічко закрите. Виділення із статевих шляхів слизові. Визначити результат клінічного аналізу крові, сечі та ультразвукового дослідження. Встановити провідний синдром, попередній діагноз і визначити подальший шлях пацієнтки. Розробити заходи щодо профілактики здорового способу життя та врахувати легальні й етичні аспекти ведення пацієнтки.

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення
Гемоглобін (г/л)	120
еритроцити ($10^{12}/л$)	3,7
Кольоровий показник	0,89
Тромбоцити ($10^9/л$)	235,5
ШЗЕ (мм/год)	15
Лейкоцити ($10^9/л$)	5,3
Лімфоцити %	20
Еозинофіли %	0
Паличкаядерні нейтрофіли %	6
Сегментоядерні нейтрофіли %	71
Моноцити %	3

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення
Кількість	60 мл
Колір	Світло-жовтий
Прозорість	прозора
Питома вага	1,004
Білок	немає
Цукор	немає
Мікроскопія сечового осаду	
Лейкоцити	5-6 у п/з
Еритроцити	1-2 екз у п/з

Циліндри гіалінові	2-3
Солі	немає
Слиз	немає
Бактерії	немає

Ультразвукове дослідження вагітності



Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнткою, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог. Мене звати...
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення клінічного дослідження (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнтки	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «Скарги на підвищення артеріального тиску 150/90 мм.рт.ст.»
2.2	Анамнез життя	Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» Очікувана відповідь: «ГРВЗ, дитячі інфекції.»
2.3	Менструальна функція	Сказати: «Чи були порушення менструального циклу до вагітності?» Очікувана відповідь: «Ні»

3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Стан задовільний, серцево-судинна та дихальна системи: без порушень.

3.2	Акушерське обстеження	Сказати: Матка в фізіологічному тонусі. Спинка плода ліворуч та кпереди. Передлежить голівка плода. ЧСС плода 140 уд / мин.
3.3	Піхвове дослідження	Сказати: Шийка вкорочена. Зовнішнє вічко закрито. Виділення слизові.
3.4	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе відчуваєте? » Очікувана відповідь: добре
4. Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Сказати: норма
4.2	Визначити результат клінічного аналізу сечі	Сказати норма
4.3	Визначити результат ультразвукового дослідження	Сказати- плід відповідає терміну вагітності
4.4	Визначити провідний синдром	Сказати- Гіпертензивний
4.5	Встановити клінічний діагноз	Сказати : Вагітність 32 тиж. І позиція, передній вид, головне передлежання. Гестаційна артеріальна гіпертензія.
21. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення вагітної	Сказати : госпіталізація у стаціонар для збереження вагітності
22. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати :- Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень. Контроль артеріального тиску. Дієта з обмеженням солі, збагачена білками та вітамінами.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		

7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати- Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при вашому стані.</i> <i>Можливі прееклампсія та еклампсія,</i> <i>За рахунок зниження фето-плацентарного кровотоку: затримка внутрішньоутробного розвитку плоду, гіпоксія плоду, гіпотрофія плоду</i>
---	---	---